

Gestante de 33 semanas con sangrado vaginal indoloro

Caso clínico de Obstetricia · Nivel: estudiante de grado · Código: OB-05

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Nadia E. K.
Edad	35 años
Profesión	Ingeniera
Estado civil	Casada
Fórmula obstétrica	G3 P2 A0 (dos cesáreas previas)
Edad gestacional	33 + 1 semanas

Motivo de consulta

Sangrado vaginal rojo brillante, abundante e indoloro, que ha empezado de repente en reposo.

Antecedentes

Personales	Sin enfermedades relevantes. Dos cesáreas anteriores.
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Dos cesáreas previas. En la ecografía de las 20 semanas le comentaron que "la placenta estaba baja" y debía repetir control.
Hábitos	No tabaco, no alcohol.

Historia de la enfermedad actual

Estando en reposo nota de forma brusca sangrado vaginal rojo vivo, abundante, sin dolor ni contracciones. No traumatismo ni relaciones sexuales recientes. Movimientos fetales presentes. No refiere pérdida de líquido. Algo asustada por la cantidad de sangre.

Exploración física

TA 110/68 mmHg, FC 96 lpm, afebril. Abdomen blando, NO doloroso, útero relajado (tono normal). NO se realiza tacto vaginal hasta descartar placenta previa por ecografía. Especuloscopia cuidadosa: sangre roja procedente de cavidad uterina, cérvix cerrado. FCF 148 lpm.

Pruebas complementarias disponibles

- Ecografía: placenta de inserción baja que cubre el orificio cervical interno (placenta previa oclusiva). Dada la historia de cesáreas, se valora acretismo placentario (signos ecográficos sugestivos).
- RCTG: FCF reactiva, sin desaceleraciones, sin dinámica.
- Hemograma: Hb 11,0 g/dL. Coagulación normal.
- Grupo y Rh, pruebas cruzadas solicitadas.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Nadia, 35 años, embarazada de 33 semanas, con dos cesáreas previas. Estás asustada porque has empezado a sangrar de repente, sangre roja y abundante, pero NO te duele la tripa. Hablas con normalidad. Cuentas, si preguntan, que en una ecografía te dijeron que la placenta estaba baja. Insistes en que no has tenido golpes ni relaciones. El bebé se mueve. Preguntas si vas a necesitar cesárea otra vez.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Hemorragia del tercer trimestre por placenta previa oclusiva (sangrado rojo, indoloro, útero relajado), con riesgo de acretismo placentario por las cesáreas previas.

Diagnóstico diferencial

- Desprendimiento prematuro de placenta (abruptio)
- Rotura uterina
- Vasa previa
- Sangrado de origen cervical/vaginal (cervicitis, pólipos)

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Características del sangrado: rojo, indoloro, espontáneo (sugiere previa) frente a doloroso con hipertonía (sugiere abruptio).
- Antecedente de placenta baja y de cesáreas (riesgo de previa y acretismo).
- Valorar repercusión hemodinámica y bienestar fetal.

Pruebas que debería solicitar

- Ecografía para localizar la placenta ANTES de cualquier tacto vaginal.
- RCTG.
- Hemograma, coagulación, grupo y Rh, pruebas cruzadas.
- Valoración de acretismo (ecografía/RM) por antecedente de cesáreas.

Manejo / tratamiento correcto

NO realizar tacto vaginal hasta descartar previa. Ingreso, reposo, monitorización materno-fetal. Estabilización hemodinámica y reserva de sangre. Corticoides para maduración pulmonar (33 semanas). Sulfato de magnesio para neuroprotección si parto inminente. Si sangrado masivo o compromiso materno-fetal: cesárea urgente. Si se estabiliza: manejo expectante hospitalario y cesárea programada (con planificación de posible acretismo: equipo multidisciplinar, banco de sangre, posible histerectomía).

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Caracteriza el sangrado (rojo, indoloro, útero relajado) y lo diferencia del abruptio	20
EVITA el tacto vaginal hasta localizar la placenta por ecografía	20
Solicita ecografía + hemograma + coagulación + grupo y pruebas cruzadas	15
Diagnostica placenta previa	15
Sospecha acretismo por las cesáreas previas y lo investiga	15
Plan: ingreso, corticoides, estabilización y planificación de cesárea	15
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Realizar tacto vaginal y provocar sangrado masivo.
- Confundir con desprendimiento sin valorar el tono uterino ni el tipo de dolor.
- No reservar sangre ni anticipar acretismo en paciente con cesáreas previas.
- Olvidar los corticoides de maduración.